

Sexualité

A. La sexualité dans le couple

1. Investigation sexologique

Les dysfonctionnements sexuels (souffrance et/ou difficultés relationnelles) peuvent être causés par une maladie somatique (diabète), des troubles psychiatriques (dépression) ou des effets de médicaments. Les problèmes sexuels au cabinet, puisqu'on estime que 10% des consultations ont pour origine une dysfonction sexuelle. Les principaux problèmes sexuels touchent les catégories suivantes :

- **Désir** : absence, aversion, excès
- **Excitation** : lubrification, érection
- **Plaisir** : anorgasmie, précoce ou tardif
- Autres : vaginisme, dyspareunie (chercher des perturbations dans le développement)

On rencontre aussi des problèmes **d'identité de genre, des préférences ou des paraphilies** (se concentrer sur un aspect partiel pour diminuer l'angoisse). Ces problématiques touchent **beaucoup plus les hommes** que les femmes. Finalement, on rencontre des situations d'abus et de violence (femmes >>> hommes), des comportements à risque.

2. Anamnèse sexuelle

- **Ouverture ou portes d'entrée**
- **Nommer le climat émotionnel**
- Langage adapté (signification des mots)
- **Investigation ≠ inquisition**
- Symptôme : caractérisation, contexte et rapport à la biographie
- Troubles du désir, de l'excitation et du plaisir avec souffrance associée

3. Facteurs d'influence

La sexualité du couple est influencée par plusieurs facteurs : **l'individu/le couple, la culture, le corps et le contexte socio-historique**. La sexualité est marquée par une grande sensibilité sociale, notamment lors des attentats d'Orlando. Le discours du président français est passé de "liberté de **choisir** son orientation sexuelle" à "liberté de **vivre** son orientation sexuelle".

3.1 Individu/couple

Il n'existe **pas de cohérence** entre sexe, genre, orientation et désirs sexuels, toutes les combinaisons sont **possibles**. Il faut donc éviter les attitudes et les discours normatifs.

3.2 Culture, mythe et religion

Il est important de différencier le fait social du fait culturel. Le social correspond à comment la société s'organise (lois et règles de vie), tandis que le culturel correspond à la symbolisation qui nous lie dans une communauté. L'origine de l'homme et de la femme varie en fonction des différentes croyances. On peut soit avoir un **être indifférencié** au départ qui se scinde en un homme et une femme, soit la version qui dit que la **femme découle de l'homme** (deux êtres différenciés dès le départ).

Il est évident que la religion a un impact important sur la sexualité, impact qui varie en fonction du degré d'intégrisme. Dans le christianisme, la sexualité est associée à la reproduction et si ce n'est pas le cas, le corps

est vu comme un péché. Dans les autres religions, la femme peut être voilé ou privée d'existence sociale, ce qui reflète **une réduction de la femme** (femme protégée ou femme impure) **mais aussi de l'homme**.

3.3 Contexte sociétal et historique

Depuis longtemps, la société et le milieu notamment familial ont **une activité de contrôle, voire de répression sur la sexualité**, que ce soit pour le genre, l'orientation sexuelle ou le désir sexuel. Il ne faut pas oublier les **dispositifs médicaux** qui ont également eu un rôle de contrôle (DSM, contraception, mouvement hygiéniste et masturbation).

Ainsi, les variations au niveau sociétal ont permis de provoquer des changements au niveau de la sexualité. Par exemple, sans les discours féministes, on n'aurait pas la sexualité que l'on a aujourd'hui. On retient cette phrase essentielle de Simone de Beauvoir, *"on ne naît pas femme, on le devient"*. En 1990, Judith Butler une philosophe féministe nous dit que l'assignation est par définition un mot et donc une illusion.

Les normes **socialement instituées et maintenues** forment la cohérence entre sexe, genre et désir sexuel et l'hétéro- sexualisation du désir institue la production d'oppositions binaires entre le féminin et le masculin. Or l'identité du genre **correspond à une histoire personnelle et culturelle** des significations reçues, prises dans un ensemble de pratiques qui renvoient à d'autres imitations et qui créent **l'illusion d'un soi genré original**. En somme, le corps **genré est performatif** (sans statut ontologique), **créé par le discours social**.

La croyance qu'il y ait un noyau interne et cohérent (sexe, genre, orientation, désir) est donc **une illusion**.

3.4 Corps

Le corps et sa sexualité ne sont **pas seulement** l'expression d'une histoire socio-culturelle. Le corps est **au centre de notre existence**, il existe par lui-même, est source de vie et nous propulse vers les autres. Il suit le principe **d'intercorporéité**, c'est à dire la recherche d'intimité et de rencontre avec autrui. Ainsi, la sexualité n'est **pas** de la mécanique !

4. Troubles sexuels et conflits

La sexualité est un **indicateur très fin** de déséquilibre conjugal, tout comme les conflits, car un couple sans conflit est un couple mort. Les dérégulations dans le couple peuvent se produire à plusieurs niveaux :

- Perception sensorielle/émotionnelle
- Événement régulier/singulier
- Partage/autosatisfaction
- Excitation/inhibition
- Relations/liens
- Emotions : joie, satisfaction/angoisse, honte, culpabilité
- Capacités phantasmatiques divergentes

4.1 Thérapies des dysfonctions sexuelles

- **Approches psychodynamiques** : recherche des angoisses (inconscientes, de blesser, de décevoir, d'être rejeté), des pouvoirs exercés (privation de plaisir, domination-soumission), des liens biographiques, etc.
- **Approches systémiques** : sexualité comme symptôme de dysfonctionnement relationnel, communication dans le couple, investigation circulaire des représentations et émotions, etc.
- **Approches cognitivo-comportementales** : modifications de représentations, exercices progressifs
- **Approches spécifiques** : sexologie, corporelles, etc.

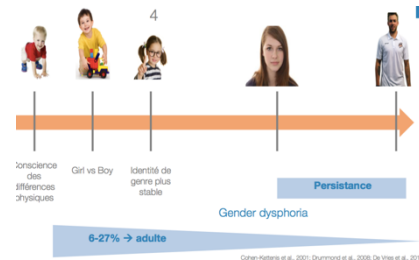
B. Développement de l'orientation et des pratiques sexuelles à l'adolescence

Dans notre société, la sexualité est un thème **omniprésent et vendeur**. Pour bien appréhender la sexualité de l'adolescent, il faut la voir dans une perspective développementale, c'est à dire qu'il y aura beaucoup d'ajustements à faire :

- Découvrir son **identité et son orientation**
- **Rapport à son propre corps et rapport au corps de l'autre**
- Apprentissage de la relation intime
- **Communiquer** autour de l'intimité
- **Respecter** ses besoins et ceux des autres

1. Développement de la sexualité psycho-émotionnelle

Le développement de la sexualité psycho-émotionnelle commence déjà *in-utero*, avec la succion du pouce qui peut être associée à du plaisir. Ensuite, entre **1-2 ans**, l'enfant prend conscience **des différences physiques**, puis à l'âge de **3 ans**, ces différences sont claires et on rencontre de l'auto-érotisme. **Vers 4 ans on a une identité de genre plus stable**.



Pendant toute la période de l'enfance, on retrouve le gender play, c'est à dire **l'adoption de comportements de l'autre sexe, avec un intérêt en lien avec le sexe opposé**. Le *gender play* est dans la grande majorité des cas transitoire puisqu'il va durer quelques jours, semaines ou mois. Cependant, on estime que dans 6-27% des cas, le *gender play* va **continuer** et les enfants se sentent toujours transgenre. Finalement, pendant **l'adolescence**, une partie de cette catégorie va manifester une dysphorie de genre. La dysphorie de genre est le plus souvent **persistante** et se traduit par **une véritable souffrance**.

2. Phases développementales

Adolescence	Début (12-14 ans)	Moyen (15-16 ans)	Fin (> 17 ans)
Intimité	Amis du même sexe	Importance des amis de sexe opposé	Relation de couple plus stable
Sexualité	Besoin d'intimité	Comportements exploratoires	Orientation/identité sexuelle acquise

3. Questions relatives à l'orientation sexuelle

Les signes faisant suspecter des questionnements sur l'orientation sexuelle sont en général **peu spécifiques** (souvent somatiques). Il est essentiel d'aborder le problème par un questionnement actif (oser aborder la sexualité) et ne pas fixer les choses. Finalement, il faut se rendre compte que le comportement n'est pas égal à l'orientation.

4. Tendances en matière de sexualité

A 17 ans, on sait que **50-60% des adolescents** ont déjà eu une activité sexuelle. Globalement, les adolescents suisses se **protègent correctement avec le préservatif** (80%), mais on voit que dans les populations plus à risque comme les HSH, le taux d'utilisation du préservatif est en baisse depuis quelques années. L'âge du 1^{er} rapport se situe toujours aux alentours de 17 ans. Au fond, ce qui a changé depuis les années 70, ce n'est pas la sexualité mais la perception que l'on a de la sexualité, car elle a suivi **l'évolution sociologique** :

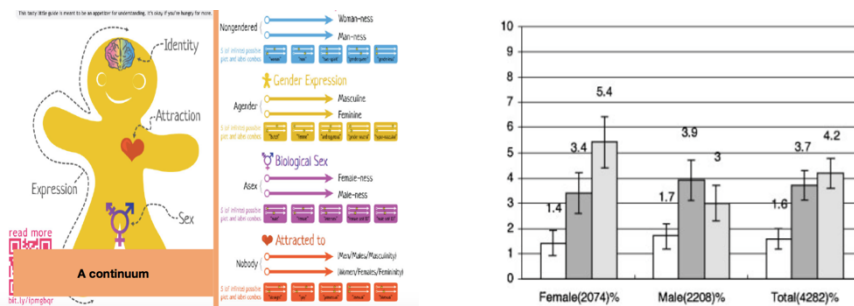
- **Années 1970** : la pilule et les antibiotiques contre Chlamydia et les gonocoques ont permis de dissocier le sexe de la reproduction.
- **Années 1980** : l'émergence du SIDA a provoqué un retour en arrière de la sexualité (perçue comme dangereuse)

- **Années 1990** : émergence d'**internet** (meilleure accessibilité aux infos) mais aussi de la pornographie de masse et des dérives facilitées (pédophilie)

5. Genderbread Person

Actuellement, on essaie de voir l'**identité de genre**, l'**expression de genre**, le **sexe biologique** et l'**attraction** (désir) comme des variables placées sur **un curseur**, avec une idée non plus dichotomique, mais de continuum.

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est important de différencier l'orientation et le comportement. On voit que si peu de personnes se disent ouvertement homosexuelles, elles sont plus nombreuses à se sentir attirée par des personnes du même sexe et **encore plus nombreuses à avoir des fantasmes homosexuels**. On comprend que la situation est donc **bien plus subtile** que simplement être ou ne pas être homosexuel.



6. Transgenre

On ne dispose pas de vraies données pour la Suisse, mais dans d'autres pays, le taux de personnes qui s'identifient comme transgenre est comprise entre 0.5-3.5%. Le pourcentage entre homme et femme est **quasiment de 50/50**. Finalement, il est important de **ne pas confondre** transgenre et transsexuel (chirurgie de réassignation).

Pour que reconnaître le patient en tant que transgenre, il faut que cet état soit **persistant, consistant et insistant** dans le temps. Le patient **pense et ressent** être de l'autre genre.

6.1 Pourquoi s'y intéresser ?

Il est indispensable de s'intéresser à cette minorité car les jeunes LGBT/trans sont **particulièrement à risque** pour plusieurs éléments désagréables et délétères : discrimination, rejet familial, harcèlement, difficulté d'accès aux soins, faible estime de soi, dépression, usage de substance, comportements agressifs et sexuels à risque.

Le **risque suicidaire** est 5x plus élevé que la moyenne chez les adolescentes homosexuelles et 7-10x plus élevé chez les transgenre. De plus, les idéations suicidaires sont **plus fortement corrélées à des tentatives de suicide** chez les jeunes LGBT que chez leurs pairs hétérosexuels. On sait que si on cherche dans le passé d'adultes transgenres, on retrouve **une tentative de suicide chez 30-50% d'entre-eux**.

7. Aborder la sexualité

On va commencer par **explorer le spectre d'identité** en veillant à adopter une attitude bienveillante, non-jugeante et en favorisant l'écoute active. Il existe des obstacles à la communication du côté de l'adolescent, mais aussi du côté du médecin :

- **Adolescent** : pudeur, gêne, difficile de croire à la confidentialité, difficulté de trouver les mots pour le dire, craintes face au jugement du praticien
- **Médecin** : crainte de devenir intrusif, difficulté de poser les questions, pudeur, gêne, réminiscence de sa propre adolescence, interférence avec son propre système de valeur

Le soutien des pairs, mais **surtout le soutien parental** est un facteur absolument indispensable pour le jeune transgenre. L'appui des parents constitue **un puissant facteur protecteur** pour la bonne santé mentale, la

satisfaction de vie, la bonne estime de soi et contre la dépression et les tentatives de suicide. Il ne faut donc pas seulement accompagner l'adolescent transgenre, mais **aussi ses parents** car cette annonce peut être vécue comme un véritable deuil ! On va commencer par essayer de gérer l'anxiété des parents, ce qui est essentiel pour la sécurité, le bien-être et l'adaptation sociale de leur enfant. On va se renseigner sur comment ils acceptent le processus de transition et quelle est la vision de l'entourage. Puis, on va essayer, avec eux, de donner du sens à ce qui leur arrive, car souvent ils se sentent coupables. Finalement, on va favoriser la compréhension en explorant et en répondant aux questions.

8. Problématiques courantes

Les dysfonctions sexuelles à l'adolescence peuvent aller **du plus banal aux choses les plus graves**. Parmi les pathologies bénignes, on retient les troubles de l'érection, la panne (banaliser en disant que c'est fréquent), l'éjaculation précoce et les anomalies mineurs de l'hymen, du pénis et des lèvres. Ensuite, plus grave, on peut avoir des dyspareunies, des accidents de préservatif et finalement des violences.

Nous abordons ici un élément inquiétant, puisque près de 30% des adolescents ont estimé que leur premier rapport est arrivé trop tôt et qu'ils n'étaient pas prêts.

Si on revient à nos jeunes transgenres, on peut **bloquer la puberté** si elle n'a pas encore débuté. Si elle a déjà débuté, on peut donner des hormones de transition **dès l'âge de 16 ans**. On procède au même suivi médical qu'une personne "normale" (frottis du col prostate). Finalement, il faut savoir que la réassignation sexuelle chirurgicale peut être envisagée **dès 18 ans**. Le traitement doit être individualisé en fonction des buts et il faut savoir que si certains éléments sont réversibles, d'autres sont irréversibles :

- **Réversible** : analogue à la GnRH, expression du genre
- **Partiellement réversible** : hormonothérapie de masculinisation ou de féminisation
- **Irréversible** : interventions chirurgicales

9. Homosexualité

Les jeunes adolescents homosexuels cumulent toute une série de facteurs de risque : moins bonne protection avec le préservatif, plus grand écart d'âge entre les partenaires, ↑ de la dépression, de l'anxiété, des symptômes fonctionnels et des IST.

10. Conclusion

Il est indispensable d'inclure systématiquement des questions sur la sexualité et la vie sexuelle dans l'anamnèse de l'adolescent. Les pratiques sexuelles des adolescents **sont stables en Suisse**. Il faut évaluer l'identité sexuelle de façon non-jugeante et soutenante et distinguer la quête sexuelle de la dysphorie. Finalement, il ne faut pas oublier les parents.

C. Sexualité féminine, quelques problèmes rencontrés en pratique médicale

Il faut savoir que le plaisir féminin résiste à bien des descriptions psychanalytiques, mais aussi biologiques ! La réponse sexuelle et le comportement se modifient pendant les différents cycles de la vie. 40% des hommes mariés et **64% des femmes mariées rapportent des plaintes concernant leur sexualité**. Les phases de **transition** sont des périodes **à risque** pour l'apparition ou l'aggravation de troubles sexuels chez la femme. Finalement, les troubles sexuels augmentent avec l'âge.

1. Composantes de la sexualité

Les oestrogènes, la testostérone et la progestérone vont agir tant au niveau du cerveau (excitation mentale, désir et satisfaction de l'orgasme) que des organes génitaux (vasocongestion, lubrification, sensation et orgasme). Les composantes sexologiques **développementales** sont les suivantes :

- **Composantes physiologiques** : excitation sexuelle et son développement

- **Composantes sexodynamiques** : sentiment d'appartenance à son sexe biologique, imagination et désir sexuel
- **Composantes cognitives** : imaginaire érotique, connaissances, idéologies et idéalizations
- **Composantes relationnelles**

Toutes ces composantes développementales sont indispensables à la **formation de l'identité sexuelle** propre à chacun.

2. Influences sur la sexualité

Une étude faite sur 3'400 femmes hétérosexuelles et en couple a montré qu'**1/3 des femmes éprouvaient de la gêne dans l'intimité sexuelle**, que seulement 1/6 des femmes avaient un rapport sexuel avec orgasme et que, **¼ des femmes accédaient rarement ou jamais à l'orgasme**. La sexualité est **influencée** non seulement par des aspects psychologiques, mais aussi par des aspects cognitifs. Chaque femme possède des connaissances et des ignorances par rapport à la sexualité et il existe dans notre société **un système de jugement de valeur et de pensée**, ce qui nous mène à **des idéologies et des idéalizations**. Tous ces facteurs sont des prismes déformants qui peuvent exercer **un rôle facilitateur ou inhibiteur** sur la fonctionnalité excitatoire.

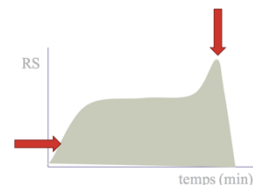
3. Codes diagnostics

Le DSM et le CIM nous donnent des définitions légèrement différentes de ce que sont les dysfonctions sexuelles. Selon le DSM, les dysfonctions sexuelles sont *des troubles du cycle de la réponse sexuelle ou douleurs pendant les activités sexuelles*, tandis que selon le CIM, le dysfonctionnement sexuel chez la femme est une difficulté à *avoir une relation sexuelle du type souhaité (satisfaisante)*. Le plus souvent se sont à la fois des aspects **psychologiques et somatiques** qui interviennent dans le déclenchement d'un trouble de la fonction sexuelle.

De manière générale, on peut dire qu'entre 20-30% de la population sans diagnostic physique, psychiatrique ou prise de médicament souffre de **troubles du désir, de l'excitation ou de l'orgasme**.

4. Physiologie

Le sexologue Kaplan a codé le fonctionnement sexuel en **trois phases caractéristiques** : désir, excitation et orgasme.



5. Pourquoi parler de sexualité ?

L'anamnèse sexuelle fait partie **intégrante de la consultation**, en particulier en présence de symptômes cliniques évocateurs. Il est important **d'intégrer les différentes étiologies non-somatiques** des troubles sexuels comme les **facteurs psychologiques, les facteurs de couple, les facteurs familiaux et les facteurs socio-professionnels**. L'information et éventuellement l'intervention précoce sont susceptibles **d'améliorer la qualité de vie et la satisfaction des patientes**.

L'évaluation doit aussi s'intéresser à **aux aspects physiques** de la patiente en la questionnant sur ses bases génétiques et hormonales, ses manifestations de l'excitation sexuelle et sa constitution physique.

6. Etiologies somatiques

Les étiologies somatiques à l'origine de dysfonctions sexuelles chez la femme sont nombreuses, mais on retient les **causes organiques** (gynécologiques, endocrinologiques, infectieuses, cardiovasculaires, neurologiques, nutritionnelles), **toxiques, médicamenteuses, psychiques ou encore relationnelles**.

7. Troubles du désir sexuel

Les **troubles du désir sexuel** sont **proportionnellement plus importants chez la femme** que chez l'homme. Parmi les troubles les plus fréquents, on retrouve **la baisse ou l'absence de désir sexuel, l'aversion sexuelle et**

le manque de plaisir sexuel. Plus rarement, on peut rencontrer une exacerbation du désir sexuel (sexual addiction).

Malgré le discours dominant, il faut se rappeler que **le plaisir sans désir est possible !**

L'activité sexuelle **n'est pas obligatoirement précédée** d'un désir sexuel (couple désirant un enfant et astreint à pratiquer des rapports dirigés.). Les partenaires sexuels peuvent répondre aux avances sexuelles de leur partenaire **même sans éprouver du désir au départ** (l'appétit vient en mangeant). Finalement, il est possible que les femmes n'aient parfois pas l'occasion de prendre conscience de leur désir sexuel avant que l'homme ne l'ait exprimé (homme souhaitant des rencontres sexuelles très fréquentes).

7.1 Conditionnement du désir et étiologies

La présence de désir sexuel dépend, selon Kaplan, des facteurs suivants :

- Facteurs biologiques et hormonaux
- Self-estime **adéquate** et capacité d'acceptation d'être une personne sexuelle
- Expériences passées **positives avec la sexualité**
- Partenaire approprié et attractif

La **perturbation ou l'absence** d'un ou plusieurs de ces facteurs peut provoquer la baisse du désir sexuel. De plus, **l'anxiété, la dépression et le stress** sont également des perturbateurs important non seulement du désir, mais aussi de la libido.

7.2 Approches possibles

Il existe plusieurs approches possibles pour aider une femme souffrant de troubles du désir. Il faut commencer par **reconnaître et accepter le désir génital**, puis **cultiver le désir** (fantasmes, jeux de rôle, attente), **mais aussi le susciter.**

8. Troubles de l'excitation sexuelle chez la femme

Le trouble de l'excitation sexuelle chez la femme se manifeste principalement par **un échec de la réponse génitale**. La difficulté à la réponse génitale correspond à une incapacité répétée et persistante d'atteindre ou de maintenir une vasocongestion suffisante. Le trouble de l'excitation est caractérisé par **l'absence ou l'insuffisance, persistante ou récurrente, complète ou partielle, de lubrification vaginale comme réponse à la stimulation sexuelle.**

8.1 Modifications physiologiques pendant l'excitation

Les expressions physiques de l'excitation sont la vasocongestion et une modification du tonus par des réaction myotoniques. Les autres réactions possibles sont des réactions kinésiques, rythmiques et une modification de la respiration. Il existe **une concordance significative entre l'excitation physiologique et l'appréciation subjective du degré d'excitation sexuelle.**

La modification du tonus et les mouvements myotoniques sont dus à l'activation des muscles **ischio et bulbocaverneux**.

8.2 Perception de l'excitation

Les perceptions corporelles (repères sexocorporels) chez l'individu sont définis par la localisation des sensations (repérage), l'analyse sensorielle spontanée ou exploratoire (mise en mot) et par la codification (enfance ou adolescence).

9. Estime de soi adéquate

La satisfaction vis-à-vis de **son propre corps** (*body cathexis*) est significativement liée à la satisfaction vis-à-vis de soi. Ce phénomène est **plus marqué chez les femmes** que chez les hommes. Par exemple, on parle du sexe de l'homme comme d'un "bijou de famille", tandis que le sexe de la femme est souvent perçu par ces dernières comme moche ou dégoûtant et il existe de nombreuses tentatives pour essayer de l'embellir. Il y aura évidemment **des difficultés supplémentaires en cas de changement de l'image corporel**.

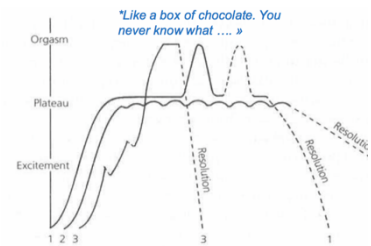
9.1 Digression sur le sein

Le mamelon est composé de cellules musculaires lisses et d'un réseau dense de terminaisons nerveuses. Son **érection** contrairement au pénis n'est pas provoqué par un engorgement de sang mais **par une contraction musculaire**. L'érection du mamelon n'est en soi **pas un indice d'excitation sexuelle**. De plus, le mamelon peut ne pas être érigé malgré une excitation sexuelle.

10. Troubles de l'orgasme chez la femme

Les troubles de l'orgasme rassemblent les orgasmes qui **ne surviennent pas ou qui sont nettement retardés**. Plus concrètement, il s'agit d'une **inhibition ou d'une absence récurrente ou persistante** de l'orgasme **après un phase d'excitation sexuelle** que les cliniciens jugent **adéquate dans l'intensité et la durée**. On peut aussi le définir comme une incapacité d'atteindre l'orgasme après masturbation ou coït. Il est important de différencier les troubles de l'orgasme primaire des troubles de l'orgasme secondaire.

Si la femme possède toutes une série de zones érogènes, **seules deux zones orgasmogènes** ont été clairement identifiées : le clitoris et le point G (plus selon certains chercheurs). Nous avons déjà vu les différentes réponses sexuelles, mais ce modèle a été repris et précisé par *Masters and Johnson*. On commence avec le désir, puis l'excitation, le plateau, l'orgasme et enfin la résolution. Ils ont également mis en réponse trois types de réponses sexuelles possibles :



- Phase d'excitation suivie d'un orgasme multiple
- Excitation qui atteint le plateau mais sans orgasme
- Phase d'excitation en palier suivie d'un orgasme

a. Etiologies des anorgasmies

On retrouve plusieurs catégories d'anorgasmies : **organiques, primaires, secondaires ou encore circonstanciels**.

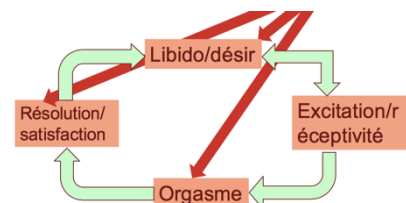
Causes psychologiques

Parmi les causes psychologiques d'anorgasme, on retient **l'anxiété, la peur, la culpabilité**, la dyspareunie ou encore les troubles du désir.

Causes organiques

Parmi les causes organiques, on retient surtout **les causes hormonales et médicamenteuses**. Les **antidépresseurs**, quels qu'ils soient ont tous un effet inhibiteur de l'orgasme chez la femme.

On a essayé d'expliquer les perturbations de la fonction sexuelle féminine par un modèle circulaire. La **dyspareunie et/ou le vaginisme** altère la libido/le désir, la satisfaction et l'orgasme. Ensuite, tous ces éléments vont **déteindre négativement l'un sur l'autre** et poursuivre la mécanique du cercle vicieux.



Une enquête a montré que **95%** des femmes qui se masturbaient arrivaient à **un ou plusieurs orgasmes, à n'importe quel moment sans pénétration vaginale**. Le taux d'orgasme chute à **44%** lorsque la stimulation clitoridienne est faite par le partenaire.

b. Innervation des organes génitaux externes et internes

On différencie l'innervation de type somatique (sensomotrice) de l'innervation de type viscérale (neuro-végétative).

- **Innervation somatique** : organes génitaux externe, partie inférieure du vagin (entrée du vagin) et musculature périnéale ⇨ perceptions précises et localisées pour tout stimulus, ✅ stimulation par des caresses.
- **Innervation viscérale** : deux tiers supérieurs du vagin ⇨ sensibilité restreinte, perceptions vagues, difficiles à localiser, ✅ stimulation par des pressions appuyées

Les femmes reprochent souvent aux hommes les éléments suivants : il se rend trop vite vers le clitoris, il appuie trop fort, il n'a pas le bon rythme ou change trop souvent de rythme. En fait, beaucoup d'hommes caressent le clitoris de leur partenaire **de la même façon qu'ils se masturberaient**, c'est-à-dire avec force, fermeté et rapidité.

c. Point G

Le point G est parfois comparé au tissu prostatique féminin. Il s'agit **d'un tissu érectile situé autour de l'urètre** dans la paroi vaginale antérieure, à **2 centimètres** de l'entrée des cellules glandulaires qui s'abouchent à des canaux excrétoires à côté du trajet urétral. On pense qu'il est présent chez près de **80% des femmes**, mais sa localisation précise est **très variable** :

- **Près de l'orifice méatique** (majorité des cas)
- Près de l'embouchure urétrale dans la vessie
- Disséminé le long du trajet urétral

La posture **du lotus renversé** est une des nombreuses variantes décrites dans le recueil *Le Jardin parfumé*. Elle est recommandée aux hommes qui pensent avoir un petit pénis, mais l'intérêt réside surtout dans le fait que **le bassin est soulevé et donc le vagin relevé**. Ce type de position permet donc une stimulation profonde.

11. Troubles sexuels avec douleur

La dyspareunie est caractérisée par des **douleurs génitales persistantes ou récurrentes associées au coït**. Elle se manifeste par des douleurs parfois des brûlures, des démangeaisons, des irritations à la pénétration, et peuvent survenir **pendant le RS ou après**. Son incidence est peu claire, on sait que **60% des femmes** sexuellement actives ou qui l'ont été **ont eu une dyspareunie**. La dyspareunie peut être superficielle ou profonde et pour les différencier, il faut **rechercher et exclure des causes somatiques** comme des infections vaginales, des malformations hyménales ou vaginales, une sécheresse vaginale, une cervicite, une vaginite, une PID, de l'endométriose ou encore des MGF.

La dyspareunie du *post-partum* est une sous-catégorie spéciale. On sait que **plus le périnée est déchiré, plus le risque de dyspareunie est augmenté**. Attention, le risque de dyspareunie augmente après l'accouchement, même en présence d'un périnée intacte. De plus, 1/4 des femmes qui ont accouché disent observer une diminution de leur plaisir et des difficultés à atteindre l'orgasme.

12. Vaginisme

Le vaginisme est une **contraction involontaire des muscles vulvopérinéaux** (muscle pubo-coccygien qui entoure le tiers inférieur du vagin) qui **s'oppose** à toute tentative de pénétration vaginale. La fréquence est difficile à évaluer car beaucoup de patientes ne le disent pas. La contraction des muscles vulvopérinéaux est **involontaire et incoercible**. Elle est déclenchée par **une perturbation émotionnelle**, qui débute par une peur panique qui se déclare devant toute perspective de pénétration.

13. Conclusion

Un bon gynécologue doit procurer le sentiment d'être écoutée, il doit reconnaître des douleurs coïtales ou d'autres plaintes sexuelles. Il doit aussi aider à la reprise de confiance dans son corps et ses habilités sexuelles et finalement **contribuer aux apprentissages du fonctionnement sexuel**.

D. Dysfonction érectile

Le sexe est partout, il est porteur et il fait vendre. La sexualité et l'amour sont de composantes qui peuvent s'associer et dans ce cas, **une altération de l'un peut entraîner une dégradation de l'autre**.

1. Fonctions et bienfaits de la sexualité

La sexualité a une fonction reproductrice, mais surtout non-reproductrice (1.7 enfant en moyenne par femme contre 5'000-6'000 rapports sexuels au cours d'une vie). La sexualité est une source de plaisir, un facteur d'intégration sociale, un facteur de renforcement du couple et un réducteur de la tension et du stress.

Plus on fait l'amour, plus on est heureux. Ceux qui font l'amour 2-3x/mois sont 33% plus enclins à se déclarer heureux que ceux qui sont restés abstinents les 12 derniers mois. Ceux qui le font **2-3x/semaine sont 55% à se déclarer plus heureux**. Finalement, ceux qui ont 2-3 rapports/mois mais qui pensent que les autres en ont chaque semaine ne sont que 14% à se sentir plus heureux. Dans des conditions de vie similaires, la mortalité globale est inférieure de 50% chez les hommes qui ont la plus grande fréquence d'orgasme. Les hommes qui font l'amour 2x/semaine, ont **2 fois plus de chances de vivre 10 ans de plus**.

2. Risques de la sexualité

Les principaux risques de la sexualité sont la mort ("*la vie est une maladie sexuellement transmise et toujours mortelle*") et les maladies sexuellement transmises. Le risque de faire un infarctus du myocarde **non-fatal** dans les deux heures qui suivent un rapport est similaire à celui de mourir dans un accident de la circulation (200/100'000). En somme, mieux vaut renoncer à sa voiture qu'au sexe !

3. Evolution de l'érection : de la psyché aux artères

En 1500, Léonard de Vinci affirmait que l'érection n'était **qu'une question de sang** : "*En ce qui concerne le membre viril lorsqu'il est dur, il est épais et long, dense et lourd, et lorsqu'il est flasque, il est étroit, court et mou, c'est-à-dire flasque et faible. La cause n'en doit être attribuée à aucune addition de chair ou d'air, mais de sang artériel*". La première cause de mortalité chez l'homme c'est les maladies cardiovasculaires (tabagisme, hypertension, hypercholestérolémie, surpoids, stress, diabète). Une des manifestations des MCV c'est l'athérosclérose. Or l'ATS est un **phénomène généralisé** qui peut également toucher **les artères présentes dans le pénis**.

50% des patients qui font un infarctus du myocarde n'ont jamais présenté de symptômes cardiaques avant de faire leur infarctus. Il existe donc un certain intérêt à **rechercher des signes annonciateurs**.

La verge est un bon témoin de l'état du système artériel.

La dysfonction érectile est un marqueur précoce de la maladie vasculaire. Les facteurs de risque cardiovasculaires apparaissent progressivement au cours de la vie. On d'abord les prédispositions génétiques, puis la dyslipidémie et ensuite éventuellement le tabagisme, l'hypertension et le diabète. La dysfonction érectile est un des marqueurs les plus précoces de la maladie vasculaire, avant l'infarctus du myocarde et **bien avant** les artériopathies oblitérantes et les accidents cérébrovasculaires.

La DE est un marqueur précoce, car elle survient en moyenne **3 ans avant tout autre événement** cardiovasculaire conséquent. On peut l'expliquer par **le petit diamètre des artères pénienues** (1-2 mm), contre respectivement 3-4mm pour les coronaires et 5-7 mm pour la carotide.

Il faut expliquer **simplement au patient** le phénomène de l'érection. L'activité sexuelle varie beaucoup au cours de la vie, mais on retrouve des similarités entre les pays. L'activité sexuelle maximale est comprise entre 30-49 ans, puis le pourcentage d'hommes sexuellement actif va progressivement diminuer. Fait étonnant, **entre 70-79 ans**, selon les études, on a encore **entre 50-70% d'hommes sexuellement actifs**. C'est une réalité, et pourtant, la société a de la peine à accepter certaines choses à partir d'un certain âge et le cas pour le sexe chez les seniors.

4. Dysfonction érectile : définition et incidence

La dysfonction érectile est une **incapacité persistante à obtenir et/ou maintenir une érection pénienne suffisante pour des rapports sexuels satisfaisants**. Elle touche plus de **50% des hommes après 40 ans**, les formes minimales et modérées sont plus fréquentes que les formes complètes. On estime que la DE va toucher potentiellement 325 millions de personnes en 2025.

La DE ne touche pas seulement l'homme, mais elle se répercute sur la femme. Ainsi, l'incidence des dysfonctions sexuelles féminines (troubles de la libido, de la lubrification et de l'orgasme) est beaucoup plus importante (double, voire triple) chez les femmes avec un partenaire souffrant de DE. Cependant, la femme de l'homme impuissant ne facilite pas toujours les choses car elles peuvent faire des remarques qui vont amplifier le problème (*si tu m'aimais vraiment tu pourrais, si tu ne pensais pas à une autre tu pourrais...*). Si la femme de l'impuissant joue **parfois** un rôle facilitateur, inhibiteur ou de maintien, elle joue **toujours un rôle dans le pronostic**.

En Suisse, le taux de divorce est d'environ 43% et on estime qu'une **dysfonction sexuelle** en est à l'origine dans **22% des cas**.

5. Facteurs de risque

Les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et des troubles érectiles **sont identiques !**

5.1 Tabac

Sur une période d'observation de 8 ans, le risque de développer une DE est de 24% chez les fumeurs et de 14% chez les non-fumeurs. Le risque double est **quasiment doublé** (1.26 contre 2.31) quand on passe de moins de 30 cigarettes à plus de 30 cigarettes par jour. **L'arrêt du tabac après 40 ans ne permet malheureusement pas** de récupérer une fonction érectile normale chez la plupart des gros fumeurs ! Cependant, 24 heures après l'arrêt du tabac (chez des grands tabagiques de plus de 40 ans), l'enregistrement des érections nocturnes montre **déjà des améliorations dans les mesures de la tumescence et de la rigidité** (mesures au Doppler).

En somme, concernant les effets de l'arrêt du tabac sur la fonction érectile, on a **des résultats discordants** qui vont varier fortement en fonction de **l'âge du patient, de l'importance et de la durée du tabagisme et de la sévérité de la dysfonction érectile**.

5.2 Excès de poids

Près de 30% des Suisses sont en surpoids, et 7% d'entre-eux sont obèses. Un suivi sur 8 ans a montré qu'un **BMI supérieur à > 28 augmente le risque de DE**. Le RR est là encore doublé en fonction de la sévérité du surpoids. Il est à 1.5 avec un BMI compris entre 25-30 et il passe à **3 avec un BMI > 30**.

La perte pondérale peut avoir des effets sur la fonction érectile, mais cela dépend des méthodes mises en œuvre. Une étude a suivi 20 obèses morbides sur 2 ans. La moitié ont été opérés, l'autre moitié a été mise sous régime et exercices. Les résultats diffèrent grandement entre les deux catégories :

- **Opération** : grande réduction du BMI, meilleure érection, meilleure testostérone et FSH et diminution de la prolactine
- **Régime et Exercices** : petite réduction du BMI et **aucun impact sur les autres facteurs !**

5.3 Activité physique

L'inactivité physique est un **facteur de risque indépendant** de DE. Il existe une **association linéaire** entre l'importance de l'activité physique et le risque de trouble érectile. Une activité physique **fréquente et intense réduit d'environ 30%** le risque de troubles érectiles. 31.8% des hommes qui sont sédentaires souffrent de DE contre seulement 13.9% des hommes avec une activité physique (> risque de DE de 2.5x). Un homme sédentaire peut réduire son risque de dysfonction érectile en déployant une **activité physique quotidienne** consommant 200kcal/j soit l'équivalent d'une promenade de 3.5 km/j

Une étude qui a suivi 60 hommes pendant 3 mois a montré **qu'une activité physique de 3-4 heures par semaine associée à l'IPDE5 est plus efficace** que l'IPDE5 seul sur **tous les paramètres de la sexualité**, c'est à dire le désir sexuel, la fonction érectile et le taux de satisfaction.

6. Couple et DE

En cas de difficultés sexuelles dans le couple, il existe plusieurs types de sexothérapies, notamment l'approche TCC, la sexoanalyse, la sexocorporelle, l'hypnose et la psychothérapie psychodynamique. Il existe bien évidemment certains types de patients qui **ne peuvent pas bénéficier** d'une sexothérapie, par exemple les psychopathes tributaires de médication lourde, les alcooliques, les toxicomanes, les patientes solitaires, les couples inégalitaires ou encore les patients qui n'ont pas le temps.

7. Traitement médicamenteux

Les inhibiteurs de la 5PDE sont **simples, très efficaces (80%) et bien acceptés**. Il faut savoir que pour que l'inhibiteur de la 5PDE fonctionne, il faut qu'il y ait une stimulation et une excitation. Les causes les plus fréquentes d'interruption du traitement sont **une efficacité en-dessous des attentes**, puis un coût élevé et une perte d'intérêt pour le sexe.

Pour les patients souffrant de **diabète**, on peut proposer des injections intra-caverneuses. Cette méthode est très efficace, mais elle est très **souvent rejetée par les patients (80%)**. On peut aussi proposer des injections **intra-urétrales** qui sont **mieux acceptées** par les patients diabétiques, mais donc **l'efficacité est moindre**. On peut aussi proposer des pompes à vide. Elles sont peu discrètes et bloquent l'éjaculation. Elles sont contre-indiquées en cas de **trouble de la crase ou de traitement anticoagulant**.

Finalement, en dernière solution, on peut placer **des prothèses péniennes**. Le taux de satisfaction est très bon, mais il faut penser **aux complications potentielles importantes** comme l'infection, les perforations, les douleurs chroniques et la défaillance technique. De plus, ce système est non-pris en charge par la caisse maladie et coûte entre 1'500 et 9'000.-

8. Conclusion

Un trouble érectile peut être équivalent à **un test d'effort pathologique** et **en cas de facteurs de risque CV**, il faut évoquer la possibilité d'une **atteinte vasculaire systématique**. En plus du traitement du trouble érectile, il convient de supprimer les facteurs de risques cardiovasculaires. La dysfonction érectile peut par différentes mesures être prévenue.